

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSÉ DA SILVA SAURO**

O artigo publicado nos Anais da Academia Nacional de Medicina apresenta o conceito atual da inflamação crônica da asma classificada com T2 e não T2. Os principais pontos abordados nessa publicação científica pelos autores são:

{{O Cenário da Asma Grave e Inflamação}}

A asma deixou de ser vista como uma doença única para ser entendida como um processo heterogêneo. O artigo destaca a divisão das vias inflamatórias:

- Via Tipo 2 (T2-Alta): Envolve a cascata de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, muito associada a quadros alérgicos e eosinofílicos. É a via com biomarcadores mais consolidados e tratamentos direcionados.
- Via Tipo 1 (T1 ou Não-T2): Caracterizada por um perfil neutrofílico ou paucigranulocítico, resistência a corticosteroides e predomínio de citocinas como IFN- γ e TNF- α , ainda carecendo de marcadores clínicos validados na rotina.

Biomarcadores Avaliados na Prática Clínica

O estudo revisa a utilidade e a aplicabilidade de marcadores mensuráveis para prever desfechos e respostas terapêuticas:

- Eosinófilos no Sangue e Escarro: Indicadores indireto e direto do nível de atividade inflamatória eosinofílica nas vias aéreas.
- Frações de Óxido Nítrico Exalado (FeNO): Um biomarcador não invasivo crucial para monitorar a inflamação brônquica e a adesão ao tratamento.
- Imunoglobulina E (IgE) Sérica: Fundamental para a identificação do fenótipo da asma alérgica/atópica tradicional.

Impacto no Tratamento Personalizado

A identificação precisa desses biomarcadores é o pilar que dita o sucesso no uso de terapias biológicas e imunobiológicas, como anticorpos monoclonais anti-IgE, anti-IL5 e anti-IL4/13). Eles garantem que o paciente receba o medicamento direcionado à sua assinatura molecular específica, reduzindo crises e o uso deletério de corticoides sistêmicos.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira